# 医院员工培训守则

新员工入职 · 医疗安全核心制度 · 心肺复苏 · 院感防控 · 设备维护

| | | | |
|---|---|---|---|
| 文件编号 | YZ-TR-2026-01 | 版本 | V1.2 |
| 生效日期 | 2026 年 10 月 | 修订周期 | 每年一次 |
| 编制部门 | 医务处 · 护理部 · 院感科 · 医学装备科 | 适用范围 | 全院在职员工 |
| 密级 | 院内公开 | 归口管理 | 人事科 |

【合成演示数据】本手册由项目脚本生成，仅用于系统演示与测试，不可用于实际诊疗或管理决策。

# 一、总则

## 1.1 目的

为规范新员工入职培训，统一医疗安全底线要求，明确急危重症处置、院感防控与设备管理的基本动作，特制定本守则。

## 1.2 适用范围

全院在职员工，包括医师、护士、医技、药学、行政、后勤人员，以及进修人员、实习学生和外包驻场人员。

## 1.3 培训要求

- 新员工须在入职 1 周内完成必修科目，1 个月内完成岗位专项培训。
- 新员工岗前培训不少于 24 学时，在职员工年度复训不少于 8 学时。
- 理论考核 80 分及以上、操作考核合格，方可独立上岗；两次补考仍不合格者暂停独立执业。
- 培训与考核记录由人事科统一归档，保存期限不少于 3 年。

## 1.4 守则效力

本守则与科室专项操作规程同时执行；两者不一致时，以更严格的规定为准。违反本守则造成不良后果的，按医院相关制度追责。

# 二、新员工入职与医疗安全核心制度

## 2.1 入职办理流程

| 序号 | 环节 | 责任部门 | 时限 | 需提交材料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 报到登记 | 人事科 | 入职当日 | 身份证、学历证、执业资格证 |
| 2 | 体检与健康档案 | 体检中心 | 3 个工作日内 | 体检报告、疫苗接种记录 |
| 3 | 岗前培训 | 医务处 / 护理部 | 5 个工作日内 | 培训签到表、考核成绩 |
| 4 | 科室带教 | 所在科室 | 1 个月内 | 带教计划、带教记录 |
| 5 | 授权与考核 | 医务处 | 考核合格后 2 个工作日 | 授权申请表 |
| 6 | 工牌与系统权限 | 信息科 | 授权后 1 个工作日 | 权限申请单 |



院内文件 · 合成演示数据

## 2.2 医疗质量安全核心制度（十八项）

以下十八项制度为全院强制执行的底线要求，各科室不得另行简化：

| | | |
|---|---|---|
| 1. 首诊负责制度 | 2. 三级查房制度 | 3. 会诊制度 |
| 4. 分级护理制度 | 5. 值班与交接班制度 | 6. 疑难病例讨论制度 |
| 7. 急危重患者抢救制度 | 8. 术前讨论制度 | 9. 死亡病例讨论制度 |
| 10. 查对制度 | 11. 手术安全核查制度 | 12. 手术分级管理制度 |
| 13. 新技术和新项目准入制度 | 14. 危急值报告制度 | 15. 病历管理制度 |
| 16. 抗菌药物分级管理制度 | 17. 临床用血审核制度 | 18. 信息安全管理制度 |

说明：十八项制度的具体执行标准见各制度单行文件；本守则仅作总纲提示，培训考核以单行文件为准。

## 2.3 培训科目与考核方式

| 培训科目 | 学时 | 考核方式 | 合格标准 |
|---|---|---|---|
| 医院文化与规章制度 | 4 | 线上答题 | ≥ 80 分 |
| 医疗质量安全核心制度 | 6 | 笔试 | ≥ 80 分 |
| 心肺复苏与急救流程 | 4 | 模拟人实操 | 操作评分 ≥ 85 分 |
| 医院感染防控 | 4 | 线上答题 + 手卫生实操 | 两项均合格 |
| 医疗设备使用与维护 | 2 | 现场演示 | 能独立完成日检 |
| 医患沟通与知情同意 | 2 | 情景演练 | 合格 |
| 信息系统与病历书写 | 2 | 上机操作 | 完成一份模拟病历 |

说明：心肺复苏为全员必修，每年复训一次；麻醉、急诊、ICU、手术室人员每半年复训一次。



院内文件 · 合成演示数据

# 三、心肺复苏（CPR）标准操作与急救流程

## 3.1 标准急救流程

注：每次按压中断不超过 10 秒；按压者每 2 分钟轮换一次，轮换在 5 秒内完成。

图 1 成人心肺复苏（CPR）标准急救流程（院内版）

## 3.2 高质量胸外按压要素

| 要素 | 标准 | 常见错误 |
|---|---|---|
| 按压部位 | 胸骨下半部，两乳头连线中点 | 位置偏低压迫剑突 |
| 按压深度 | 5~6 cm | 深度不足或超过 6 cm |
| 按压频率 | 100~120 次/分 | 过快导致回弹不充分 |
| 胸廓回弹 | 每次按压后完全回弹 | 手不离胸、持续下压 |
| 按压中断 | 每次中断 < 10 秒 | 频繁摸脉、整理设备 |
| 按压通气比 | 30:2（建立高级气道后改为连续按压） | 通气过多、过度通气 |

### 3.3 除颤与药物

| 环节 | 操作要点 | 参数 / 剂量 |
|---|---|---|
| 除颤时机 | 室颤或无脉性室速立即除颤，电极板涂导电糊并压实 | 双相波 120~200 J |
| 除颤后 | 立即恢复按压，2 分钟后再次评估心律 | 不检查脉搏 |
| 肾上腺素 | 静脉推注后用 20 ml 生理盐水冲管 | 1 mg，每 3~5 分钟一次 |
| 胺碘酮 | 第 2~3 次除颤后仍为室颤 / 无脉室速时使用 | 首剂 300 mg，可追加 150 mg |
| 可逆病因 | 按 5H5T 排查：低血容量、低氧、酸中毒、电解质紊乱、低体温；张力性气胸、心包填塞、中毒、肺栓塞、冠脉血栓 | 每轮循环复查 |

### 3.4 团队分工与复苏后处理

- 按压者每 2 分钟轮换一次，轮换在 5 秒内完成，避免疲劳导致深度不足。
- 气道管理者负责球囊面罩通气与高级气道建立；记录者负责计时、给药与事件记录。
- 组长负责决策与除颤，不参与具体操作，确保全局观察。
- 自主循环恢复后：收缩压维持 ≥ 90 mmHg，SpO2 94%~98%，PaCO2 35~45 mmHg，并启动目标温度管理（32~36 °C，维持 24 小时）。

## 四、医院感染防控与职业暴露处理规范

### 4.1 手卫生五个时刻

| 时刻 | 指征 | 方式与时长 |
|---|---|---|
| 接触患者前 | 进入床单元、握手、查体前 | 速干手消毒剂 20~30 秒 |
| 清洁 / 无菌操作前 | 置管、换药、注射、导尿前 | 流动水洗手 40 秒或速干手消毒 |
| 体液暴露风险后 | 接触血液、体液、分泌物、伤口敷料后 | 流动水 + 皂液洗手 40 秒 |
| 接触患者后 | 查体、协助翻身、更换床单后 | 速干手消毒剂 20~30 秒 |
| 接触周围环境后 | 接触床栏、床头柜、监护仪后 | 速干手消毒剂 20~30 秒 |

### 4.2 标准预防要点

- 所有患者的血液、体液、分泌物均视为具有潜在传染性，接触时按标准预防执行。
- 预计接触血液体液飞溅时，加戴护目镜或面屏；操作前后执行手卫生。
- 一次性物品不得重复使用；可复用器械使用后立即预处理并密闭转运。
- 发生职业暴露后 2 小时内上报，不得隐瞒或延迟。


院内文件 · 合成演示数据

### 4.3 职业暴露处置流程

| 步骤 | 操作要点 | 时限 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| 1 局部处理 | 锐器伤由近心端向远心端挤出血液，流动水冲洗 5 分钟，75% 乙醇或碘伏消毒；黏膜暴露用大量生理盐水反复冲洗 | 立即 | 暴露者 |
| 2 上报 | 报告科室负责人，填写职业暴露登记表 | 2 小时内 | 暴露者 / 科室 |
| 3 评估 | 院感科评估暴露源（HBV / HCV / HIV / 梅毒）与暴露程度 | 24 小时内 | 院感科 |
| 4 预防用药 | HBV 暴露按需注射乙肝免疫球蛋白并接种疫苗；HIV 暴露 2 小时内启动阻断用药，最迟不超过 72 小时 | 越早越好 | 感染科 |
| 5 随访 | 按病原体潜伏期复查（HIV：4 周、8 周、12 周、6 个月） | 按计划 | 院感科 |

### 4.4 医疗废物分类

| 类别 | 常见物品 | 包装与标识 |
|---|---|---|
| 感染性废物 | 被血液体液污染的棉球、纱布、一次性手套、引流袋 | 黄色专用袋，标注「感染性废物」 |
| 损伤性废物 | 针头、刀片、玻璃安瓿、缝合针 | 黄色利器盒，装载不超过 3/4 |
| 病理性废物 | 手术及病理取材后的组织、器官 | 专用容器，低温暂存 |
| 药物性废物 | 过期、变质或被污染的药品 | 单独收集，交药学部统一处置 |
| 化学性废物 | 甲醛、二甲苯、含汞器械 | 专用容器，交有资质单位处置 |

## 五、医疗设备日常维护与检查

### 5.1 日常检查要求

- 每日首次使用前完成外观、电源、报警与附件的四项检查，并填写检查记录表。
- 生命支持类设备（呼吸机、除颤仪、输液泵）须每日测试报警功能，每周核对电池续航。
- 发现异常立即停用、挂「故障」标识、移出诊疗区域，并在设备管理系统报修。
- 设备档案、维修记录、计量检定证书由医学装备科统一保管，保存期限不少于 5 年。



院内文件 · 合成演示数据

### 5.2 医疗设备日常维护与检查记录表

使用说明：每台设备每日检查后填写；发现异常立即停用、挂「故障」标识并报修；本表每月交医学装备科归档。

| 日期 | 设备名称 / 编号 | 外观与电源 | 报警与显示 | 附件与耗材 | 结论 | 检查人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | □正常<br>□异常 | □正常<br>□异常 | □齐全<br>□缺失 | □可用<br>□停用 | |
| | | □正常<br>□异常 | □正常<br>□异常 | □齐全<br>□缺失 | □可用<br>□停用 | |
| | | □正常<br>□异常 | □正常<br>□异常 | □齐全<br>□缺失 | □可用<br>□停用 | |
| | | □正常<br>□异常 | □正常<br>□异常 | □齐全<br>□缺失 | □可用<br>□停用 | |
| | | □正常<br>□异常 | □正常<br>□异常 | □齐全<br>□缺失 | □可用<br>□停用 | |
| | | □正常<br>□异常 | □正常<br>□异常 | □齐全<br>□缺失 | □可用<br>□停用 | |

### 5.3 故障报修流程

- 第一步：立即停止使用，断开电源，挂「故障待修」标识，移出诊疗区域。
- 第二步：在设备管理系统提交报修单，注明设备编号、故障现象、发生时间。
- 第三步：医学装备科 2 小时内响应；生命支持类设备 30 分钟内到场，必要时调配备用机。
- 第四步：维修完成后由科室设备管理员验收，记录维修内容与更换配件，方可重新投入使用。

## 六、培训考核与附则

### 6.1 考核与上岗

新员工完成全部必修科目并通过考核后，由医务处或护理部核发上岗授权；未取得授权者不得独立值班、独立操作或独立出具报告。

### 6.2 复训与继续教育

- 全体员工每年完成不少于 8 学时的院内复训，中心肺复苏为必训项目。
- 麻醉、急诊、ICU、手术室人员每半年完成一次心肺复苏复训。
- 新发布或修订的院内制度，应在发布后 1 个月内完成全员培训。

### 6.3 附则

- 本守则由医务处负责解释，人事科负责培训档案管理。
- 本守则自发布之日起施行，原有相关规定与本守则不一致的，以本守则为准。
- 本守则每年修订一次；遇重大制度调整时及时修订并重新发布。

编制：医务处 · 护理部 · 医院感染管理科 · 医学装备科 审核：医疗质量管理委员会 批准：院长办公会



院内文件 · 合成演示数据